

(otorino)

INDICADO POR: Dra Patricia Yama
 () ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
 NS

DIVANICE MOREIRA DOS SANTOS

IDADE: 59 PESO: 77 ALTURA: 1,63 PROFISSÃO: Corretora de imóveis
 SINTOMAS: Cansaço, Refluxo, Dor nos pés saindo do hospital hoje pois operou laringectomia.
 QUEIXAS:
 MEDICAMENTOS: Lorantana / Luclide
 MÉDICO: Dra Ludmilla Coppio
 MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N
 EXERCÍCIO FÍSICO: não realiza
 HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: - JANTAR: 20h
 HORA QUE DORME: 23h HORA QUE ACORDA: 6h
 COCHILLO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE
 TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N
 BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N
 FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: raramente
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
 OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 338 SPO2: 73-1
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (X) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA
 HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:
 COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA () CARDÍACA
 (X) ORTOPÉDICA coluna (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:
 POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

Locação

08/11/24 Análise Swift Fx (S)
 14/11/24 P=7cmH2O * todo aparelho Elite por Auto set *
IAH= 0,9 e/h
maio= 7h 27 min
fuga= 7l/min Auto 4 a 12 cmH2O.
↑ umidif. G. Silvia
 25/11 P med: 10,2 cmH2O
 24 IAH= 0,3 e/h Relata ter sentido sufocamento
mdc úv: 6h 49m nas últimas noites parou
fuga: 0 diminuindo desde então

Natasha

10/12/24 P= 10,1 cmH₂O
ΔAH=0,6 e/h
mdc uso: 5h53'
fuga: 0,3 l/m

Pte decidiu desenvolver
o equipamento p/
realizar titr medicamentos

Natasha

05/03
2026

análises:

tenfina, cansaço, não consegue dormir, sentiu taquicardia ao
dormir

fez nova PSG fev/2026

ΔAH= 31 e/h
SpO₂: 64%
↑N2
↓N3
↓REM

despetou 32/h

> hip > duracp 80mg
> à E19.

vai retornar o uso hoje

locacp auto 4 à 12 cmH₂O.

a mãe já tinha suíte(s)

Nome: DIVANICE MOREIRA DOS SANTOS

Peso: 76 kg

Data de Nascimento: 10-03-1990

Altura: 1,63 m

IMC: 28,60

Médico: DRA. LUDMILLA M. COPPIO

Sexo: Feminino

Medicamentos:

Data do exame: 15-11-2023

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 15-11-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 375,5 min. As avaliações de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 34,5 e 58,5 minutos. O tempo total de sono foi de 384,0 min, eficiência de 80,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 58,7%; estágio N3: 17,1%; sono REM: 22,0%. O índice de despertares foi de 13,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 33,8/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 216 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e a mínima de 73%, permanecendo 19,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 85 bpm e a média de 66 - 68 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (0), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência de sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apneia + hipopnéias (33,8) de 33,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO2=73%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAHI: 00-10: menor leve;

IAH: 15-30: grau moderada;

IAH: > 30: grau acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Márcio Simões da Costa

CRM 57157